

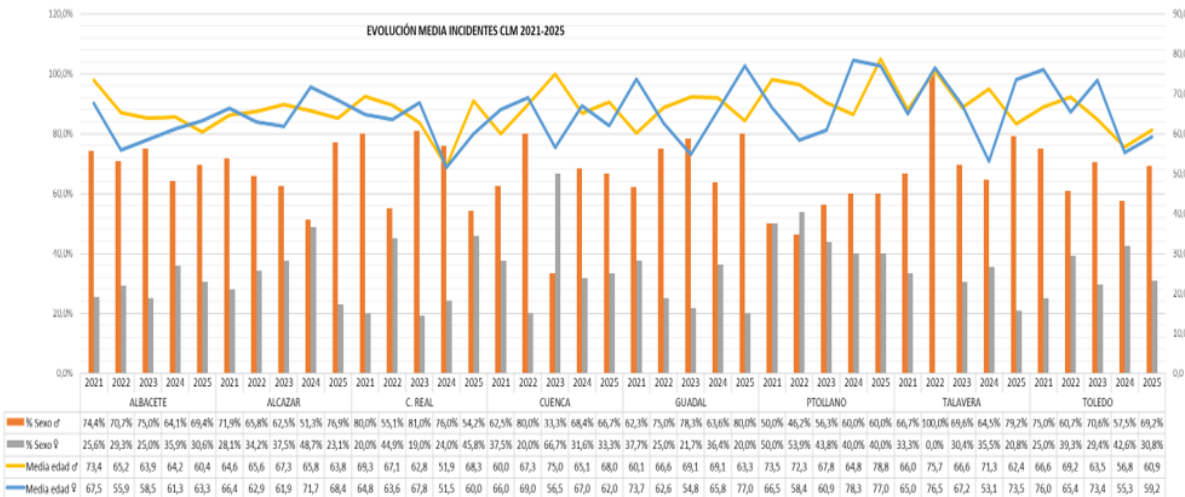
INFORME EVOLUTIVO ACTIVIDAD ASISTENCIAL E INDICADORES DE CALIDAD AVERICUM ALBACETE 2023-2025

1. NÚMERO TOTAL DE PACIENTES EN PROGRAMA DE HD POR AÑO.

1.1. PACIENTES INCIDENTES ALBACETE

Son pacientes incidentes en el centro los remitidos por el hospital de referencia a lo largo de todo el ejercicio (del 1 de enero al 31 de diciembre del año estudiado):

- Año 2023: **52 pacientes**
- Año 2024: **43 pacientes**
- Año 2025: **36 pacientes**



En la Comunidad de Castilla La Mancha los pacientes incidentes en el ejercicio 2025 disminuyen en todos los centros a excepción de Guadalajara, siendo esta disminución más significativa en los centros de Albacete, Alcázar, Toledo y Puertollano. El 70% son hombres con una media de edad de 60,4 años, el 40% mujeres, 60,33 años. En el comparativo por grupos de edad, la población de CLM es más añosa, solo el 9% son < 45 años, y hasta el 30% superan los 75 años.

	CANARIAS					ANDALUCÍA					CLM				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
< 45 años	6,9%	12,9%	8,6%	11,8%	9,8%	11,9%	13,5%	14,1%	3,1%	11,8%	5,1%	7,8%	6,9%	14,0%	9,1%
45-64 años	33,5%	33,6%	39,0%	29,7%	35,1%	22,2%	30,2%	31,4%	40,6%	21,1%	31,0%	33,3%	35,3%	27,3%	28,0%
65-74 años	31,5%	32,0%	30,2%	30,6%	25,8%	29,5%	30,2%	36,2%	22,4%	21,4%	38,3%	25,7%	27,9%	29,8%	32,5%
75-80 años	24,1%	13,9%	15,5%	20,7%	15,8%	27,8%	18,8%	9,4%	28,1%	28,9%	16,8%	18,1%	21,8%	16,9%	18,1%
> 80 años	4,0%	7,6%	6,7%	7,2%	13,6%	8,6%	7,3%	8,9%	5,7%	16,8%	8,9%	15,0%	8,1%	10,8%	12,3%

1.2. PACIENTES PREVALENTES ALBACETE (a 31 de diciembre)

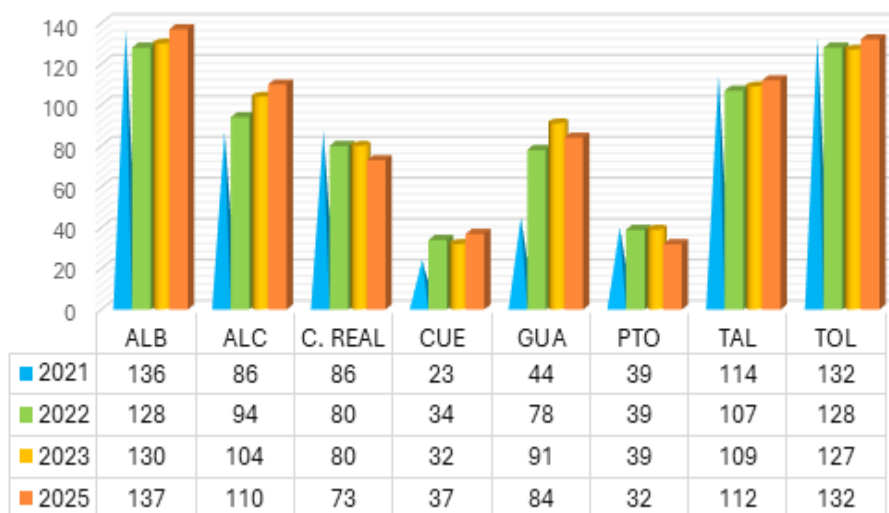
- **Número total de pacientes en programa de hemodiálisis por año.**

Los pacientes prevalentes a 31 de diciembre de los últimos ejercicios fueron:

- Año 2023: **130 pacientes**
- Año 2024: **147 pacientes**
- Año 2025: **137 pacientes**

El 70% son hombres con una media de edad de 69,39 años, 30% mujeres, 67,58 años.

EVOLUCIÓN PREVALENTES CLM 2021-2025



1.3. MORTALIDAD

- Número total de pacientes fallecidos por año.
- Tasa de mortalidad anual.
- Informes de evaluación anual del indicador, en cumplimiento de la periodicidad establecida en el pliego. Comparación, en su caso, con los estándares exigidos en el contrato.

Nº total de fallecidos por años:

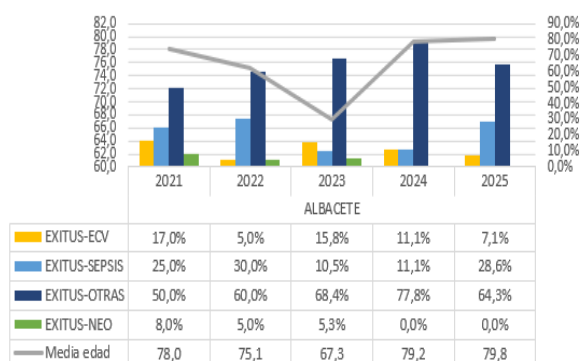
- Año 2023: 19 exitus
- Año 2024: 9 exitus
- Año 2025: 14 exitus

Tasa de Mortalidad anual:

- Año 2023: **10,4%**
- Año 2024: **4,6%**
- Año 2025: **7,9%**

Lo más relevante en el análisis de la mortalidad es el estudio de las causas de exitus y su relación directa con las complicaciones de la técnica. En el evolutivo desde el inicio de la prestación el 99% de los exitus no se relacionan con complicaciones directas de la técnica.

EVOLUCION MORTALIDAD CLM (ALBACETE) 2021 - 2025



EVOLUCION MORTALIDAD CLM (ALBACETE) 2021 - 2025



	Tasa Mortalidad centro Albacete	Tasa mortalidad nacional SEN
Año 2023	10,4%	13,8%
Año 2024	4,6%	13,3%
Año 2025	7,9%	13,4%

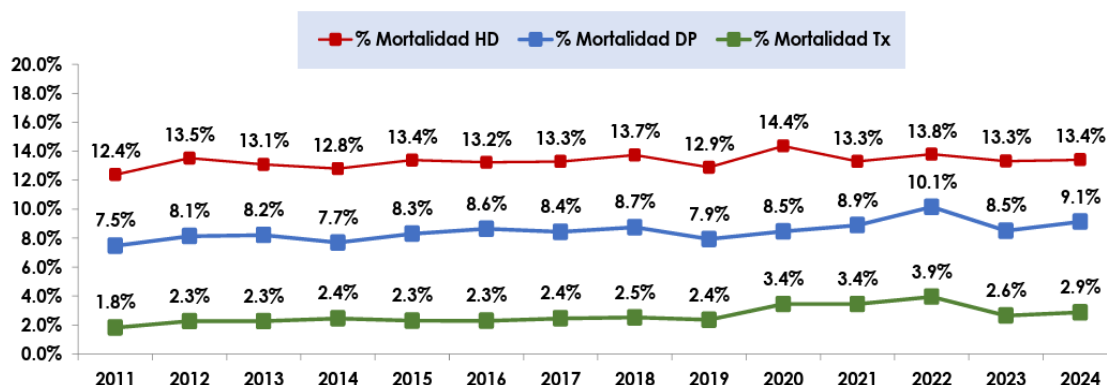
La mortalidad nacional asociada a la técnica de Hemodiálisis, en base a los registros nacionales de la SEN (REDYT) son superiores al 13% en los tres últimos ejercicios, siendo significativamente menores las tasas de mortalidad registradas en los pacientes en HD del centro de Albacete.



Mortalidad



Evolución de la mortalidad por TRS (%)



Cálculo de mortalidad: Fallecidos / prevalentes a final de año + fallecidos durante el año

1.4. TRASPLANTE RENAL

- Número de pacientes valorados para inclusión en lista de trasplante renal.
- Número de pacientes incluidos en lista de espera de trasplante renal.
- Tasa o proporción de inclusión en lista de espera.
- Informes de evaluación anual de este indicador

Pacientes incluidos:	11 (08,60%)
Pacientes pendientes de inclusión:	02 (01,73%)
Pacientes en estudio:	23 (17,78%)
Pacientes en Exclusión definitiva:	47 (35,82%)
Pacientes en exclusión temporal o hasta revalorización:	32 (24,33%)
Pacientes pendientes de valoración:	05 (03,85%)

Pacientes trasplantados: 8

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	PREVALENTES A 31 DE DICIEMBRE	n
SITUACION LE TX RENAL	Incluido	8,24%	11	9,00%	12	8,60%	11
	Pendiente inclusión	0,76%	2	1,93%	3	1,73%	2
	En estudio	17,41%	23	18,25%	24	17,78%	23
	Exc. Definitiva	39,40%	51	32,52%	42	35,82%	47
	Negativa paciente	7,58%	10	8,48%	11	8,02%	10
	Exc. Temporal	9,37%	12	17,61%	23	13,48%	18
	Exc. hasta revalorización	14,18%	18	7,58%	10	10,85%	14
	Pendiente de valoración	3,07%	4	4,63%	6	3,85%	5

A 31 de diciembre de 2024

Pacientes incluidos:	06 (04,74%)
Pacientes pendientes de inclusión:	03 (02,24%)
Pacientes en estudio:	25 (19,40%)
Pacientes en Exclusión definitiva:	41 (31,56%)
Pacientes en exclusión temporal o hasta revalorización:	36 (27,53%)
Pacientes pendientes de valoración:	06 (04,80%)

Pacientes trasplantados: 11

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	PREVALENTES A 31 DE DICIEMBRE	n
SITUACION LE TX RENAL	Incluido	4,19%	5	5,26%	7	4,74%	6
	Pendiente inclusión	2,62%	3	1,88%	3	2,24%	3
	En estudio	18,74%	24	20,03%	27	19,40%	25
	Exc. Definitiva	31,45%	40	31,66%	42	31,56%	41
	Negativa paciente	8,65%	11	10,76%	14	9,73%	13
	Exc. Temporal	24,64%	31	14,77%	20	19,59%	26
	Exc. hasta revalorización	5,64%	7	10,14%	14	7,94%	10
	Pendiente de valoración	4,19%	5	5,38%	7	4,80%	6

A 31 de diciembre de 2025

Pacientes incluidos:	09 (07,20%)
Pacientes pendientes de inclusión:	03 (02,37%)
Pacientes en estudio:	32 (24,44%)
Pacientes en Exclusión definitiva:	40 (30,93%)
Pacientes en exclusión temporal o hasta revalorización:	29 (22,01%)
Pacientes pendientes de valoración:	07 (05,18%)

Pacientes trasplantados: 10

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	PREVALENTES A 31 DE DICIEMBRE	n
SITUACION LE TX RENAL	Incluido	8,48%	11	5,94%	8	7,20%	9
	Pendiente inclusión	1,68%	2	3,03%	4	2,37%	3
	En estudio	24,35%	31	24,53%	32	24,44%	32
	Exc. Definitiva	32,84%	42	29,08%	38	30,93%	40
	Negativa paciente	8,16%	11	7,59%	10	7,87%	10
	Exc. Temporal	4,15%	5	9,73%	13	6,97%	9
	Exc. hasta revalorización	15,54%	20	14,54%	19	15,04%	20
	Pendiente de valoración	4,79%	6	5,56%	7	5,18%	7

El porcentaje de pacientes incluidos en lista de espera en cada periodo, así como el número de pacientes trasplantados viene condicionado por muchos factores ajenos a la actividad de los centros extrahospitalarios, no solo depende de la celeridad en solicitar las pruebas complementarias de los estudios sino también de los perfiles de los pacientes (edad, comorbilidad, etc), la demora de realización de determinadas pruebas diagnósticas en el hospital (Angio-TACs, cateterismos, Endoscopias..), la incidencia de patología intercurrente que requiere de determinados tiempos de espera (neoplasias tratadas, revascularización cardiaca con doble antiagregación), etc.

Para poder valorar la idoneidad del tiempo requerido en incluir un paciente en lista de espera en Albacete hemos establecido una comparativa con el centro de Toledo por presentar un número de pacientes prevalentes similar y depender de un hospital igualmente trasplantador, en el ejercicio 2025.

En cuanto a la situación actual en lista de espera es similar en ambos centros:

Situacion LE Tx	Albacete		Toledo	
	%	Nº	%	Nº
Incluido	7,75%	10	6,15%	8
En estudio	20,16%	26	26,92%	35
Exc. Definitiva/negativa paciente	37,98%	49	40,77%	53
Exc. Temporal/hasta revalorización	23,26%	30	22,31%	29
Pendiente de valoración	10,85%	14	3,85%	5

Duración del estudio desde el inicio a la conclusión (contemplando como inicio el hospitalario en los casos provenientes de ERCA o diálisis peritoneal con estudio iniciado):

	Toledo (N 17)	Albacete (N 20)
Duración estudio (meses)	14,1	18,9

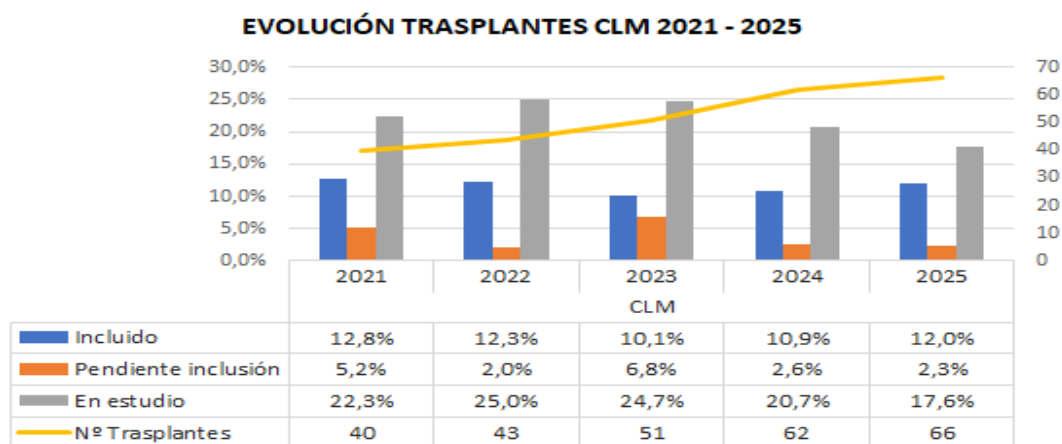
Tiempo transcurrido entre la llegada al centro, el inicio del estudio y la inclusión en lista de espera:

	Toledo (N 9)	Albacete (N 12)
Inicio centro/Inicio estudio (meses)	8,3	6

	Toledo (N 10)	Albacete (N 15)
Inicio centro / inclusion (meses)	19,4	22,4

Comparativamente, Albacete muestra una mayor duración media del estudio pretrasplante y un tiempo mayor desde el inicio en el centro hasta la inclusión del paciente en LE, a pesar de que el estudio se inicia en Albacete 2,3 meses antes que en el centro de Toledo.

Datos del global de la Comunidad Autónoma (CLM):



En la evolución a nivel de la CCAA en los últimos años ha aumentado el porcentaje de pacientes incluidos en lista de espera y el número de pacientes trasplantados.

1.5. Seguridad del paciente y prevención de complicaciones infecciosas:

- Número total de pacientes portadores de catéter tunelizado en cada periodo.
- Número de infecciones del orificio o del túnel registradas en cada periodo.
- Porcentaje de infecciones en relación con el total de pacientes portadores de catéter
- Informes de seguimiento o evaluación disponibles.

Nº total de pacientes con CVC, CVC-AVU, FAVn, FAVp y CVC+FAVn/p, por años “n” y %:

2023

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	PREVALENTES A 31 DE DICIEMBRE	n
AAVV PREVALENTES %	% P. prev. AAVV desarrollado (sin AVU)	39,81%	52	41,13%	53	40,47%	53
	% P. prev. con FAVn	33,85%	44	34,25%	44	34,05%	44
	% P. prev. CVC (No AVU)	41,54%	54	46,40%	60	43,97%	57
	% CVC-AVU	18,27%	24	12,53%	16	15,40%	20
	% P. prev. con FAVP	4,23%	6	5,33%	7	4,78%	6
	% P. prev. con CVC / FAVn	1,73%	2	1,54%	2	1,64%	2
	% P. prev. con CVC / FAVp	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

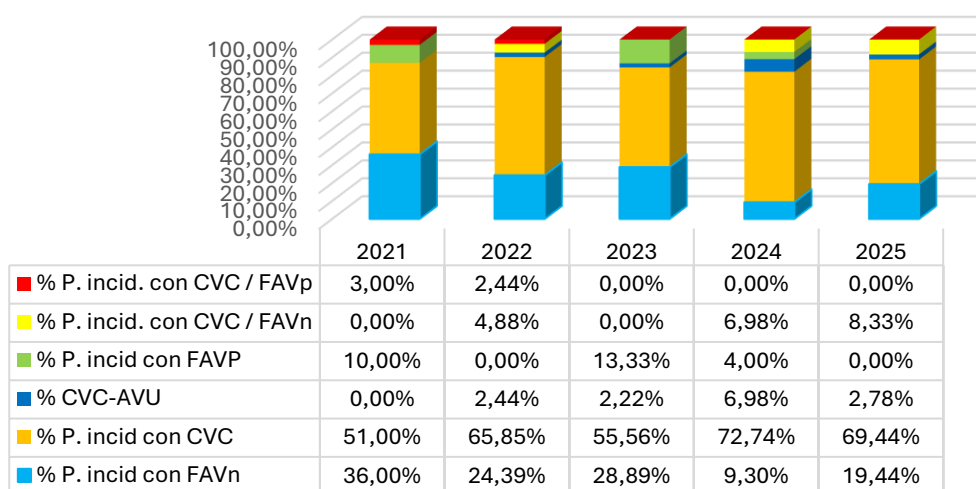
2024

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	PREVALENTES A 31 DE DICIEMBRE	n
AAVV PREVALENTES %	% P. prev. AAVV desarrollado (sin AVU)	36,96%	47	35,48%	47	36,20%	47
	% P. prev. con FAVn	30,28%	39	28,54%	38	29,39%	38
	% P. prev. CVC (No AVU)	47,97%	61	49,87%	66	48,94%	64
	% CVC-AVU	14,94%	19	14,64%	20	14,79%	19
	% P. prev. con FAVP	5,11%	7	4,94%	7	5,03%	7
	% P. prev. con CVC / FAVn	1,57%	2	1,63%	2	1,60%	2
	% P. prev. con CVC / FAVp	0,00%	0	0,38%	1	0,19%	0

2025

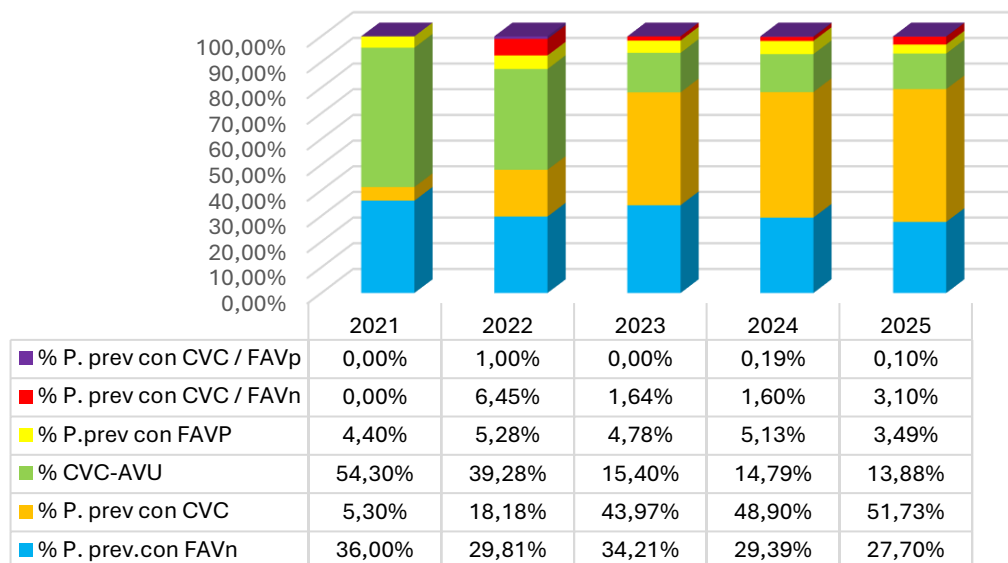
REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	PREVALENTES A 31 DE DICIEMBRE	n
AAVV PREVALENTES %	% P. prev. AAVV desarrollado (sin AVU)	33,74%	43	35,02%	46	34,39%	45
	% P. prev. con FAVn	27,46%	35	27,94%	37	27,70%	36
	% P. prev. CVC (No AVU)	52,27%	67	51,20%	68	51,73%	67
	% CVC-AVU	13,99%	18	13,78%	18	13,88%	18
	% P. prev. con FAVp	4,08%	5	2,91%	4	3,49%	5
	% P. prev. con CVC / FAVn	2,01%	3	4,17%	6	3,10%	4
	% P. prev. con CVC / FAVp	0,19%	0	0,00%	0	0,10%	0

EVOLUCION AAVV P. INCIDENTES



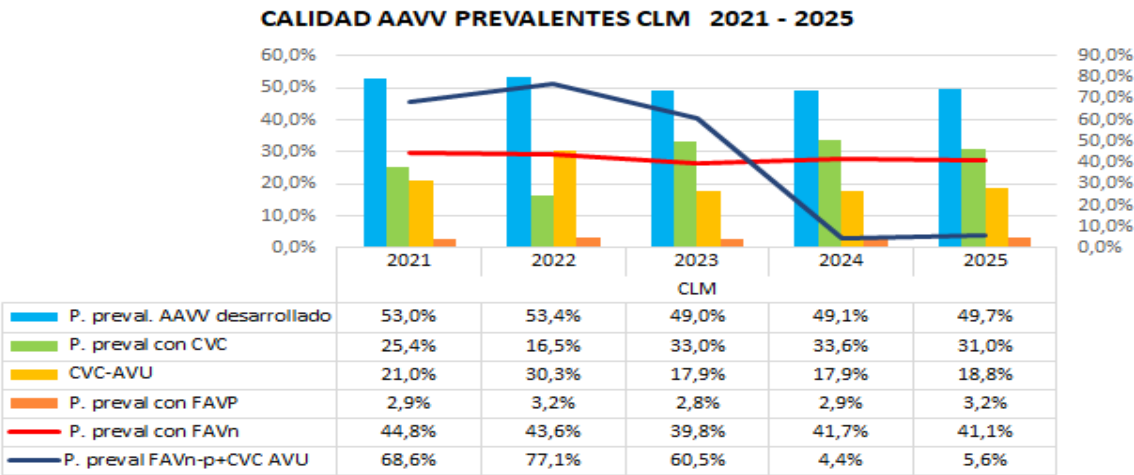
Respecto al porcentaje de pacientes incidentes con CVC, es decir el acceso vascular con el que son remitidos desde el hospital al centro de hemodiálisis en Albacete hasta el 72% de los pacientes acuden con CVC de los cuales un 53% con CVC_AVU (lo que denominamos acceso vascular único), porque presentan ya imposibilidad o contraindicación de realización de una FAV.

AAVV P. PREVALENTES



A 31 de diciembre de cada ejercicio el % de pacientes que se dializan con CVC (sin incluir CVC-AVU) es del 44% en 2023, 49% en 2024 y 52% en 2025, porcentajes muy alejados de los recomendados por la SEN, como ocurre en todos los centros de la CCAA, cuya gestión de pende de la implicación de distintos servicios hospitalarios incluyendo nefrología, Cirugía Vascular y radiología Vascular Intervencionista.

Datos del global de la Comunidad Autónoma (CLM):



En el global de centros extrahospitalarios de la CCAA en 2023 el % de pacientes dializados por CVC (sin incluir CVC-AVU) es del 33% en 2023, 34% en 2024 y 31% en 2025.

Complicaciones de los AAVV por años “n” y %:

2023

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	ANUAL	n
COMPLICACIONES AAVV	INFECCION ORIFICIO	66,67%	16	74,36%	29	71,43%	45
	TUNELITIS	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	BACTERIEMIA	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	BACTERIEMIA CON CULTIVO+	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	DISFUNCION CVC (Recambio)	12,50%	3	12,82%	5	12,70%	8
	DISFUNCION FAV (n/p)	4,17%	1	2,56%	1	3,17%	2
	INFECCION FAVn	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	INFECCION FAVp	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	TROMBOSIS FAVn	8,33%	2	7,69%	3	7,94%	5
	Nº Trombectomias FAVn	50,00%	1	66,67%	2	60,00%	3
	TROMBOSIS FAVp	8,33%	2	2,56%	1	4,76%	3
	Nº Trombectomias FAVp	50,00%	1	100,00%	1	66,67%	2
	Nº Total de complicaciones infecciosas	66,67%	16	74,36%	29	71,43%	45
	Nº Total de complicaciones	24	24	39	39	63	63

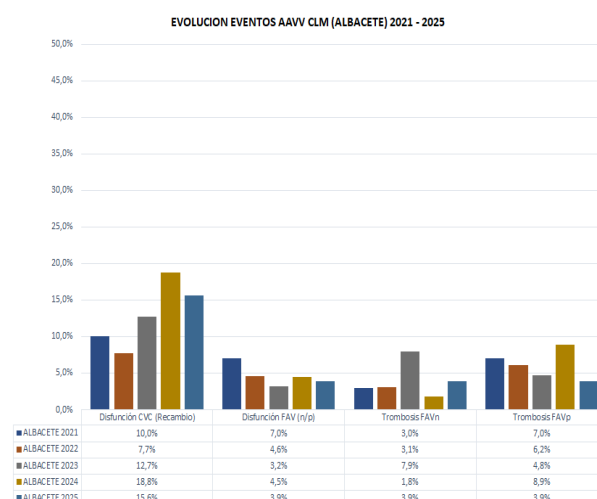
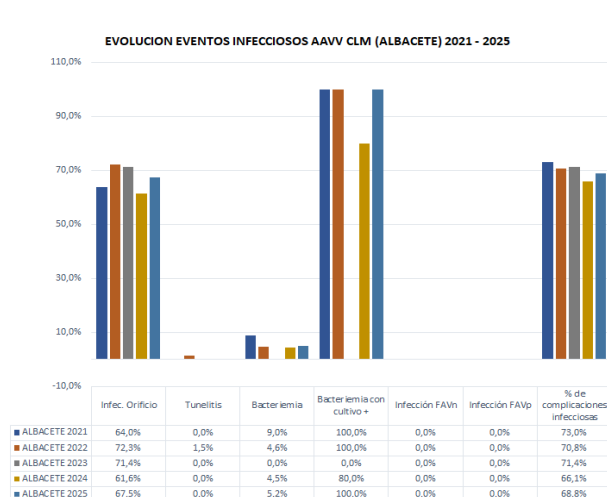
2024

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	ANUAL	n
COMPLICACIONES AAVV	INFECCION ORIFICIO	59,62%	31	69,09%	38	61,61%	69
	TUNELITIS	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	BACTERIEMIA	0,00%	2	0,00%	3	4,46%	5
	BACTERIEMIA CON CULTIVO+	100,00%	2	66,67%	2	80,00%	4
	DISFUNCION CVC (Recambio)	25,00%	13	14,55%	8	18,75%	21
	DISFUNCION FAV (n/p)	5,77%	3	3,64%	2	4,46%	5
	INFECCION FAVn	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	INFECCION FAVp	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	TROMBOSIS FAVn	1,92%	1	1,82%	1	1,79%	2
	Nº Trombectomías FAVn	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	2
	TROMBOSIS FAVp	7,69%	4	10,91%	6	8,93%	10
	Nº Trombectomías FAVp	75,00%	3	100,00%	6	90,00%	9
	Nº Total de complicaciones infecciosas	61,11%	33	70,69%	41	66,07%	74
	Nº Total de complicaciones	52	54	55	58	112	112

2025

REGISTROS MEDICOS INDICADORES		PRIMER SEMESTRE	n	SEGUNDO SEMESTRE	n	ANUAL	n
COMPLICACIONES AAVV	INFECCION ORIFICIO	59,46%	22	75,00%	30	67,53%	52
	TUNELITIS	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	BACTERIEMIA	10,81%	4	0,00%	0	5,19%	4
	BACTERIEMIA CON CULTIVO+	100,00%	4	0	0	100,00%	4
	DISFUNCION CVC (Recambio)	16,22%	6	15,00%	6	15,58%	12
	DISFUNCION FAV (n/p)	2,70%	1	5,00%	2	3,90%	3
	INFECCION FAVn	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	INFECCION FAVp	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
	TROMBOSIS FAVn	5,41%	2	2,50%	1	3,90%	3
	Nº Trombectomías FAVn	50,00%	1	100,00%	1	66,67%	2
	TROMBOSIS FAVp	5,41%	2	2,50%	1	3,90%	3
	Nº Trombectomías FAVp	100,00%	2	100,00%	1	100,00%	3
	Nº Total de complicaciones infecciosas	70,27%	26	67,50%	27	68,83%	53
	Nº Total de complicaciones	37	37	40	40	77	77

El número total de complicaciones asociadas al AAVV de cualquier tipo en los últimos ejercicios se expresa en las tablas anteriores, un total de 63 en 2023 de los cuales 45 eran de origen infeccioso, 112 en 2024 (74 de origen infeccioso, la mayoría, 69 infecciones de orificio), y 77 en 2025, 53 de origen infeccioso (52 infecciones de orificio), las tasas de bacteriemia y trombosis son similares a las reportadas en otros centros de la CCAA y



Evolución de los Indicadores de la SEN desde 2020

INDICADORES DE CALIDAD	OBJETIVOS	2020	2021	2022	2023	2024	2025
% Pacientes Incidentes con Acceso vascular desarrollado	>75%	47%	49%	34%	42%	13%	28%
% Pacientes Incidentes con catéteres permanentes	<10%	53%	51%	66%	55%	74%	72%
% Pacientes Prevalentes con Fístula (acceso definitivo) /+ CVC-AVU	>80%	43/52%	40/94%	42/81%	40/56%	38/53%	35/48%
% De pacientes con KTV (Daugirdas) igual o >1,3	≥ 88%	88%	90%	90%	ND	ND	ND
% Pacientes con hemoglobina (10-12g/dl). Hb >11 gr/dl	≥ 85%	65%	64%	71%*	71%	70%	76%
% pacientes con ferritina en rango óptimo (200-600)/100-500	>80%	60%	55%	68%**	57%	62%	55%
Tiempo medio en hemodiálisis convencional de la población prevalente	≥ 12 horas semanales	11,15	10,84	11,2	10,59	11,22	11
% pacientes con PTH-i entre 150 y 300 pg/ml	>30%	45%	44%	41%	41%	34%	33%
% de determinaciones de fósforo < 5.5 mg/dl	>70%	89%	89%	82%	83%	79%	77%
Tasa bruta de mortalidad	< 13%	6,58%	6%	11%	11%	5%	8%
Media de albúmina	Sin definir	3,92	3,84	3,91	3,87	3,89	3,9
Pacientes incluidos en LE de trasplante renal	Sin definir	14	12	10 (9%)	11(9%)	6 (5%)	9(7%)

1.6. Datos periodo 1 de enero a 30 de abril de 2026:

Nota: Los datos de calidad no pueden calcularse en períodos inferiores a un año, porque a pesar de que los indicadores pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, **el solicitado, esto es, la tasa de mortalidad no puede ser más que anual.** El resto de los períodos no tienen relevancia científica.

- Número total de pacientes en programa de hemodiálisis.
- Número de pacientes fallecidos.
- Tasa de mortalidad acumulada a abril 2026.
- Informe del indicador
- Número de pacientes valorados para inclusión en lista de trasplante renal.

En el centro Avericum Albacete a fecha 30 de abril reciben tratamiento un total de 137 paciente, con una edad media de 67,97 años (32-90)

MES	ENE	FEB	MAR	ABR
Pacientes al inicio del mes	137	138	135	138
Pacientes incorporados	4	4	11	1
Pacientes transferidos	1	2	4	0
Pacientes Exitus	1	5	4	0
Pacientes Trasplantados	1	0	0	0
Pacientes al final del mes	138	135	138	137

En la tabla adjunta se puede observar que han llegado al centro 20 pacientes incidentes y han fallecido 10 pacientes por causas no relacionadas con la técnica.

De ellos:

- 1 por sepsis abdominal
- 1 por neoplasia activa
- 1 por abandono de la técnica
- 7 por otras causas.

En relación con la gestión de la lista de espera de trasplante renal, a fecha de hoy hay 27 pacientes en estudio para inclusión y 10 pacientes incluidos en lista, representan el 23,25% de la lista de lista de espera del hospital de Albacete, que incluye además de la provincia de Albacete los pacientes de Alcázar de San Juan y Cuenca.

Durante el periodo contemplado un paciente del centro ha sido trasplantado.

En cuanto a la situación actual del AAVV, la población del centro se dializa un 72,2 % por CVC (99 pacientes), 4 pacientes por FAVp y 34 pacientes por FAVn (27,7% con FAV).

Este elevado número de catéter provoca que se hayan registrado 23 infecciones de orificio, no obstante, no se han producido tunelitis o bacteriemias.

Otras incidencias registradas del acceso vascular en el periodo son 2 roturas de CVC que han precisado recambio y 2 trombosis de la FAV sin trombectomía.

En definitiva, en estos cuatro meses la evolución de los datos no siendo comparables a los registros previos (anuales), se pueden considerar superponibles.

4 de mayo de 2026

Firmado por ANTON PEREZ,
MARIA GLORIA (FIRMA) el
día 04/05/2026 con un

Fdo. Gloria Antón
Directora médica Avericum

Firmado por VALDES
SOTOMAYOR, JORGE DANIEL
(FIRMA) el día 04/05/2026
con un certificado emitido
por AC DNIE 005

Fdo. Jorge Valdés
RMA de Avericum Castilla La Mancha